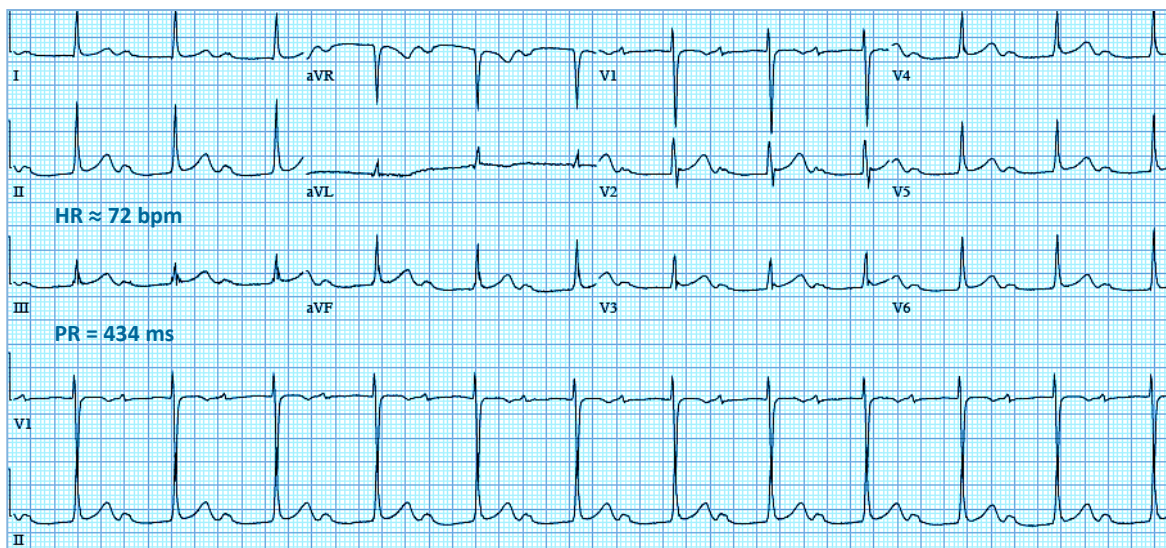


1^ο Βαθμού Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός

- Πρόκειται, ίσως, για την πιο κοινή διαταραχή αγωγιμότητας (άνδρες/γυναίκες: 2/1) και χαρακτηρίζεται από την παράταση του PR διαστήματος ($PR > 0,20$ sec). Το ερέθισμα, εδώ, παράγεται φυσιολογικά στο φλεβόκομβο και μεταδίδεται κανονικά στους κόλπους, αλλά η κάθοδος του ερεθίσματος στο κοιλιακό μυοκάρδιο καθυστερεί στην περιοχή του κολποκοιλιακού (κ-K) κόμβου ή χαμηλότερα στο σύστημα αγωγής.



- Σε περιπτώσεις όπου η παράταση του διαστήματος PR συνοδεύεται και από αποκλεισμό του δεξιού (RBBB) ή του αριστερού σκέλους (LBBB), αυτό σημαίνει ότι η διαταραχή της αγωγιμότητας εντοπίζεται χαμηλά στο στέλεχος ή στα σκέλη του δεματίου του His και η κατάσταση αυτή, καθώς και η πρόγνωση στην περίπτωση αυτή, είναι σοβαρότερη.
- Μπορεί να εντοπιστεί τυχαία σε φυσιολογική καρδιά (ιδίως σε νέους αθλητές σε ποσοστό 10-30%) ή σε αυξημένο παρασυμπαθητικό τόνο. Η ύπαρξή του σε ασυμπτωματικούς αθλητές, στους οποίους η διάρκεια του διαστήματος PR δεν αυξάνεται στην άσκηση και η μορφολογική εμφάνιση του κοιλιακού συμπλέγματος QRS είναι φυσιολογική, δεν αποτελεί αντένδειξη συμμετοχής σε ανταγωνιστικά αθλήματα. Όταν όμως υπάρχουν συμπτώματα ή όταν η διάρκεια της κολποκοιλιακής αγωγής υπερβαίνει τα 300 ms ή όταν το εύρος του QRS συμπλέγματος είναι αυξημένο, τότε πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος. Όταν το διάστημα PR παρατείνεται περισσότερο από 0,30 sec (βλ. HKΓ), τότε ο κ-K αποκλεισμός 1^ο βαθμού ονομάζεται «σημασμένος» (“marked”).
- Σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις εμφανίζεται ιδιαίτερος μετά από κατώτερο OEM (δευτερογενώς λόγω ισχαιμίας του κ-K κόμβου), σε τοξικό δακτυλιδισμό, μυοκαρδίτιδα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, υπομαγνησισαιμία), φλεγμονές και λοιμώξεις (ενδοκαρδίτιδα, ρευματικός πυρετός, νόσος Chagas, νόσος του Lyme, διφθερίτιδα, κ.ά.), υπερδοσολογία Βεραπαμίλης, β-αναστολέων ή αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης (α-MEA), Αμυλοείδωση, Σαρκοείδωση, ΣΕΛ, Σκληρόδερμα, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς δε χρήζουν κάποιας ειδικής θεραπείας. Ιδιαίτερη θεραπεία απαιτείται στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει κάποια παθολογική κατάσταση που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση του 1^ο βαθμού κ-K αποκλεισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στο γενεσιουργό παθολογικό αίτιο της αρρυθμίας. Επίσης, σε νευρομυικά ή διηθητικά καρδιακά νοσήματα ίσως χρειαστεί βηματοδότηση.
2. Αν εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα, τότε χορηγούμε 0,5 - 1,0 mg **Ατροπίνη** iv-bolus, που επαναλαμβάνεται κάθε 3-5 λεπτά, μέχρι τη μέγιστη δόση των 3 mg ενδοφλεβίως.